

INVESTIGATION PÉDIATRIQUE

CONSULTATION PÉDIATRIQUE

- Anamnèse
- Signes de danger:
 - Très petits nourrissons
 - Température: enfant très chaud
 - Traumatisme, problème chirurgical
 - Pâleur
 - Intoxication
 - Douleur
 - Détresse respiratoire
 - Enfant agité, irritable, léthargique
 - Transfert
 - Malnutrition
 - Oedèmes
 - Brûlures étendues
- Symptômes principaux:
 - Toux
 - Diarrhée
 - Fièvre
 - Oreille, ORL
- Etat nutritionnel
- Etat vaccinal
- Autres problèmes
- Suivi et organisation

STATUS DU NOUVEAU-NÉ

OBJECTIFS

- Evaluer la qualité de la croissance intra-utérine
- Rechercher une malformation ou un signe d'alarme d'une infection néonatale
- Vérifier l'adaptation à la vie extra-utérine
- Evaluer l'âge de la gestation

AVANT L'EXAMEN

Il faut connaître avant l'examen :

- Âge de gestation = DDR, US, clinique du nouveau-né (score de Dubowitz)
- ATCD familiaux
- Déroulement de la grossesse + accouchement
- Adaptation néonatale immédiate
- Premières observations néonatales

Attention :

- ⚠ **Lavage des mains**
- ⚠ **Présence de la mère (ou du père) si possible**

EVALUATION DE LA CROISSANCE INTRA-UTÉRINE

- **Poids + taille + PC** (la plus grande circonférence occipito-frontale)

SIGNES DE MATURATION SOMATIQUE et NEUROLOGIQUE (pour dét. l'âge de gestation, = Dubowitz)

Prématuré	Nouveau-né à terme
Oedèmes mains, pieds + tibia	Disparu
Peau fine et douce	Plus épaisse, avec +/- fissures superficielles des mains et des pieds
Peau rouge	Rosé pour lèvres, plantes des mains et des pieds
Veines visibles sur le tronc	Plus opaques
Lanugo (poils) sur le dos	Quasi plus si à terme
Plantes des pieds = lisse	plissée
Mamelons juste visible, pas de glande mammaire	Visibles et surélevés jusqu'à 1cm
Oreille pas finie et molle	Finie et cartilagineuse
Testicules pas palpables	Doivent être palpables
On voit les petites lèvres	Sont recouvertes par les grandes lèvres
Neurologique - Posture des membres en extension - Angle du poignet et dorsiflexion du pied élevé - Retour du bras et jambe lent et incomplet - Angle poplité élevé - Talon-oreille=0° - Signe de l'écharpe= coude dépasse la ligne médiane - Tiré assis= tête suit pas l'axe du corps - Suspension ventrale : dos rond	- En flexion - 0° - Vif et complet - 90° - Impossible - Coude reste ipsilatéral lorsqu'on met la main sur l'épaule controlatérale - Tête suit l'axe du corps - Dos plus tonique, moins incurvé

EXAMEN GÉNÉRAL

- Inspection des téguments :
 - Couleur
 - Texture
- Malformation externe
- Signes dysmorphiques

- Erythème toxique : tronc + visage dans les heures suivant la naissance
- Milium : nez (blanchâtre)
- Cyanose : lèvres, extrémité
- Anémie : pâle vs pléthore
- Vernix caséosa : enduit blanchâtre recouvre nouveau né à la naissance + persistance dans les plis cutanés en post natal
- Ictère physiologique : > 36h de vie, gencives, conjonctives
- Méconium : imprégnation méconiale sur ongles + ombilic (verdâtre)
- Mains de lavandières : desquament après quelques jours.

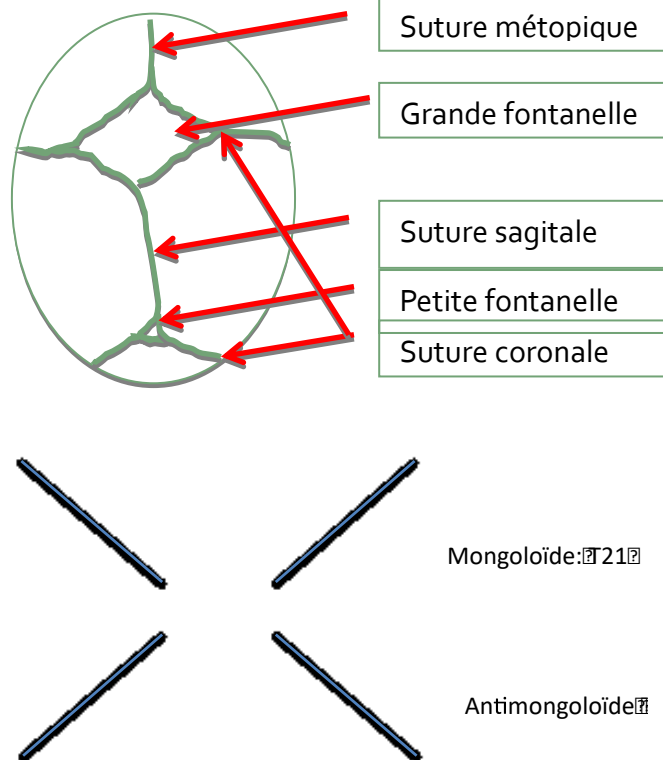
TÊTE

Palper :

- Forme du crâne :
 - Fontanelles et sutures
 - Céphalo-hématome : sous périoste, respecte les sutures
 - Bosse sério-sanguine : segment sous cutané disparaît en quelques jours
 - Craniotabes ou craniosinostose

Observer :

- Texture + implantation des cheveux / forme + structure des oreilles
- Yeux :
 - Fentes palpébrales :
 - Position
 - Taille
 - Inclinaison
 - Epicanthus : replis de peau qui couvre l'angle interne de l'œil (attention faire les reflets cornéens)
 - Hypertétorisme
 - Reflet :
 - Pupilaire -> si blanchâtre : cataracte ou rétinoblastome
 - Cornéen
 - Colobome ?
 - Oedème palpébral fréquent
- Nez : forme, ailes du nez
- Lèvres : fente palatine ?
- Menton : rétrognathisme ?
- Cou :
 - SCM : torticoli
 - Thyroïde : goître



THORAX ET ABDOMEN

- Palpation du sternum
- Écartement des mamelons + glandes mammaires (bourgeons mammaires palpables à la naissance=physiologique), mamelons supplémentaires
- Cordon ombilical:
 - Observer (il sèche et chute entre 4-10 jours, maximum 10 jours)
 - Faire le soins

DOS

- Rechercher une tâche mongoloïde sacrée (surtout si peau foncée)
- Suivre du doigt la ligne des apophyses épineuses (malformation, scoliose, etc)
- Observer le sillon inter fessier et confirmer la symétrie des plis fessiers
- Rechercher une spina bifida

MEMBRES

- Palpation (fracture, malformation), longueur
- Mains : observer
 - Plis palmaire (s'il y a uniquement un plis transverse, suspecter une trisomie 21)
 - Nombre de doigts (polydactylie)
 - Implantation du pouce
 - Formation des ongles
- Pieds : observer
 - Plis plantaire
 - Nombre d'orteils
 - Implantation de l'hallux
 - Formation des ongles
 - Pied Bot : ce n'est pas une malformation si c'est réductible par une stimulation externe de la jambe
- Hanches :
 - Manœuvre de Barlow ou Ortolani :
 - Objectif : dépister une luxation congénitale de la hanche
 - FR : anamnèse familiale positive
 - Diagnostic :
Dépistage : flexion et adduction des jambes et des cuisses puis rotation externe avec les paumes des mains contre les genoux et les index contre le grand trochanter. Si un clic sonore survient = suspicion
Confirmation par US

Lésions les plus fréquentes

- Hématome SCM
- Fracture de la clavicule (asymétrie, douleurs)
- Élongation du plexus brachial = paralysie du membre supérieur (bras en pronation et rotation interne)

EXAMEN PAR SYSTÈME

RESPIRATOIRE

- Observation :
 - La respiration : irrégulier, périodique, pause normale
 - Ampliation symétrique
 - FR = N : 30-60/min
- Auscultation : murmure vésiculaire
- SDR : urgence si >2 de :
 - Tachypnée
 - Battement des ailes du nez
 - Tirage = intercostal, sus sternal, sus claviculaire
 - Cyanose = ongles, lèvres, gencives
 - Gémissement expiratoire

CARDIO-VASCULAIRE

- Auscultation :
 - FC : 120-160/min
 - B1/B2 de tonalité différente
 - Souffle ?
- Palper les pouls surtout, le pouls fémoraux (+ huméraux + radiaux + tibial postérieur)
- Evaluer le temps de recoloration : <3 sec (tibia ant.)

DIGESTIF

- Observation de l'abdomen : globuleux (grassouillet) , symétrique
- Palpation des 4 cadrans : HSM
- Anus :
 - Position anale
 - Rechercher une perforation anale
- Selles :
 - Méconium :
 - Expulsé dans les 48h
 - Foncé et collant
 - Selles d'allaitement : jaune-or
- Omphalite : rechercher une infection et une hernie

URO-GENITAL

- Palpation bimanuelle des reins
- Observer les organes génitaux externes :
 -  :
 - Leucorrhée physiologique
 - Attention : hypertrophie clitoris -> suspecter un syndrome adrénogénital
 -  :
 - Hydrocèle physiologique

- Testicules :
Index sur canal inguinal et palper
Si absent = rechercher
- Phymosis physiologique
- Orifice urétral ? Hypospadias ?

NEUROLOGIQUE

- Influencé par l'éveil et l'âge de gestation et temps post repas (le mieux 2-3h post prandial)
- Ce qu'on teste :
 - Tonus, posture, motricité
 - ROT
 - Réflexes archaïques
 - Fonctions supérieures : vision, audition, comportement

EVEIL

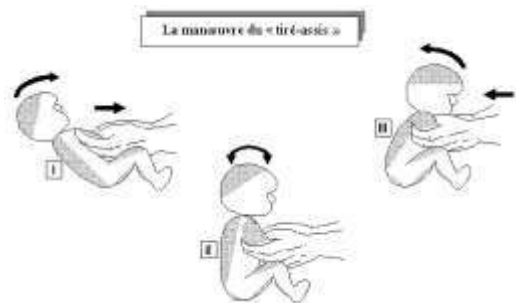
- Ouverture des yeux
- Respiration
- Motricité spontanée
- Vocalisation

Stades :

1. sommeil profond = respiration régulière, ≠ mouvements
2. sommeil léger = mouvement oculaires, respiration irrégulière
3. **éveil calme : yeux fermés ou entrouverts, activité faible**
4. **éveil + mouvement : yeux ouverts, alerte**
5. éveil + mouvement ++
6. éveil + pleurs

TONUS, POSTURE

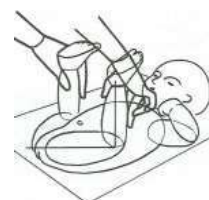
- Actif :
 - Tête dans l'axe
 - Tiré- assis
 - *Au départ, le nouveau-né est couché en décubitus dorsal. Dans un premier temps, l'examineur tire le nouveau-né par ses deux bras pour l'amener en position assise. Lorsqu'il est assis, la tête est maintenue dans le plan frontal par la contraction synergique des muscles fléchisseurs et extenseurs du cou. Dans un deuxième temps, l'examineur penche le nouveau-né en avant puis il le repousse en position assise.*
 - But : contrôle du tonus de la tête + fléchisseur de la nuque + extenseur de la nuque pour dépister un IMC. Pendant toute la manœuvre, le nouveau-né doit maintenir la tête dans l'axe du corps grâce à la contraction "anticipatrice" des muscles fléchisseurs du cou. Dans le deuxième temps, il doit y avoir une extension active de la tête, anticipée sur la position du tronc, utilisant les muscles extenseurs du cou.



- Suspension ventrale (manœuvre de Landau) :
 - *L'examineur soulève le nouveau-né en le maintenant avec la main sur le ventre.*
 - En position ventrale, le nouveau-né doit effectuer une flexion des cuisses et une extension des bras.



- Passif :
 - Position physiologique : membres fléchis
 - Test de la flexion des mains et des pieds :
 - *L'examineur fléchit/ferme les mains et les pieds du nouveau-né.*
 - Les mains et les pieds doivent revenir ouvert. Ce test permet d'examiner le tonus.
 - Traction des bras et des jambes :
 - *L'examineur étend les bras et la jambe puis il les relâche.*
 - Les membres doivent retourner en position fléchie.
 - Angle poplité :
 - *Le nouveau-né étant en décubitus dorsal. L'examineur fléchit les deux cuisses sur le bassin et les deux genoux de chaque côté de l'abdomen, puis il éloigne les jambes des cuisses (extension de jambes) jusqu'à un point de forte résistance.*
 - L'angle d'extensibilité des muscles ischio-jambiers est normalement de $\leq 90^\circ$.
 - Angle de dorsiflexion :
 - *L'examineur effectue une dorsiflexion du pied.*
 - L'angle de dorsiflexion du pied est de $0-20^\circ$.
 - Angle des adducteurs :
 - *L'examineur étend les membres inférieurs du nouveau-né et réalise une abduction des hanches en séparant les deux membres inférieurs.*
 - L'angle des adducteurs est de $40-70^\circ$.
 - Épreuve talon-oreille :
 - *L'examineur amène le talon à la hauteur en fléchissant le bassin et en tendant les jambes du nouveau-né*
 - Cette est impossible chez un enfant normal; l'angle doit être $\leq 90^\circ$.
 - Signe de l'écharpe :
 - *L'examineur rapproche une main vers l'épaule controlatérale.*
 - Le coude ne doit pas dépasser la ligne médiane.



MOTRICITÉ

- Spontanée et symétrique
- Cris normal, clair, vigoureux

ROT

- Rotulien, bicipital, etc

RÉFLEXES ARCHAÏQUES

- Marche automatique (jusqu'à 2-3 mois) et enjambement
- Réflexe de Moro :

- *L'examineur fléchit le corps du nouveau-né en poussant le dos en avant avec les mains et lâche tête en descendant les mains brusquement en arrière (les mains doivent être abaissées et non pas enlevées, pour amortir ainsi le choc).*
- Le nouveau-né va écarter les bras, puis ouvrir les mains et crier. Il est important d'avertir les parents.
- Pathologie si : fracture de la clavicule, paralysie du plexus brachial, ostéoarthrite du bras
- Réflexe de Galant :
 - Stimulation de la ligne paravertébrale du dos et de la partie distale avec un doigt
 - Le nouveau-né s'incurve le dos ipsilatéralement à la stimulation
- Stimulation des commissures labiales :
 - *L'examineur stimule avec son doigt les coins de la bouche.*
 - La stimulation des commissures labiales entraîne la rotation de la tête et l'ouverture de la bouche du nouveau-né, qui cherche ainsi à téter.
- Réflexe de succion (permet également de vérifier s'il y a une fente palatine)
- Réflexe d'agrippement ou grasping : mains et pieds
- Allongement croisé : stimulation cutanée plantaire provoque un allongement du membre controlatéral.
- Réflexe tonique asymétrique de la nuque : on met la tête sur le côté et le tonus des membres change
→ position de l'escrimeur

FONCTIONS SUPÉRIEURES

- Communication
- Comportement :
 - Rechercher le contact visuel (nuque et tête soutenu car il doit être libéré des automatismes primaires)
 - Changement d'expression du visage
- Vision :
 - Ouverture des yeux : (peut être provoqué par la succion)
 - Mouvements spontanés conjugués des yeux
 - Reflets cornéens : strabisme ?
 - Fond d'œil : leucocorie ? etc
 - Poursuite visuelle : fixe cible située entre 10 et 20 cm et la suit à gauche et à droite
- Audition :
 - Clochette : tourne la tête et les yeux vers la source sonore

PAS OUBLIER AVANT LA SORTIE

- Guthrie
- Vitamine D
- Vitamine K
- Si fièvre avant 3 mois= pas normal et consulter
- Soins du cordon 4-6 jours jusqu'à la chute (si rouge ou inflammatoire=consulter)
- Fiches d'information
- Suivi pédiatre

CONSEILS AUX PARENTS AVANT LE RETOUR À DOMICILE

ALIMENTATION

- Fréquence :
 - A la demande
 - Toutes les 3-4 heures,
 - Pas de limitations dans la durée
- Si sein préférentiel :
 - Alternier premier sein à chaque repas.
 - L'enfant peut être satisfait et rassasié avec un seul sein pendant la tétée. Si ce n'est pas le cas, donner alors les deux seins lors de la même tétée.
- Si alimentation mixte :
 - Sein/biberon en complément
 - Donner le sein en premier
- Alimentation au lait :
 - Exclusive jusqu'au 6ième mois
 - Pas de solides
 - Pas de miel
- Lait hypoallergénique :
 - Pas d'indication absolue
 - Possible pour les 4-6 mois si anamnèse familiale allergique positive chez les parents ou la fratrie et si l'allaitement est impossible
- Lait artificiel :
 - Cave, dilution lait en poudre
 - Cave, risque de sous-nutrition / intoxication à l'eau
- Règle d'alimentation :
 - Liquide dans le biberon ! Pas de céréales dans les biberons
 - Solide dans la cuillère

VITAMINES

- Vitamine D :
 - 4 gouttes/j pendant la première année de vie
 - Pas pris en charge par les assurances
- Konakion (vitamine K) :
 - 2mg à H4, J4 et J28

SIGNES ET SYMPTÔMES D'APPEL

- Fièvre avec température rectale > 38 °C, axillaire > 37,5 °C
- Deshydratation : < 1 couche mouillée / 8h ou < 3 couches mouillées / 24h
- Difficulté à réveiller l'enfant
- Irritabilité, pleurs inconsolables
- Mouvements anormaux
- Difficultés à respirer
- Ictère

VISITES CHEZ LE PÉDIATRE

- Choix du pédiatre avant retour à domicile
- Coordonner, horaire de disponibilité, numéro d'urgence
- Prévoir une première visite à 1 mois, avant si problème médical à suivre
- Visites suivantes selon le calendrier vaccinal ou si la présence de signes d'appels

SOINS DE BASE

- Cordon ombilical :
 - Sèche et tombe tout seul entre 7 et 15 jours
 - Vérifier absence de rougeur / écoulement / douleur
- Bain :
 - Eau à 37 °C
 - Courte durée
 - Savon neutre non parfumé
- Couche culote :
 - Changement de couche à chaque repas
 - Chez la fille, essuyer de haut en bas
- Transit :
 - Les allaités peuvent avoir un transit irrégulier sans forcément être constipés
 - Normalité : 7 selles / J - 1 selle / semaine -> pas de stimulation rectale avec le thermomètre
- **TOUCHER, MASSER, PARLER, INTERACTION +++**
- Pas d'automédication : **PAS D'ASPIRINIE**
- Pas de piercing avant les 3 premiers tours d'immunisations tétanos (6mois)

PRÉVENTION SIDS

- Décubitus dorsal, sur matelas ferme pour tout moment de sommeil
- Couchage simple, sans oreillers ni duvet ni grosses peluches
- Allaitement maternel recommandé
- Température ambiante chambre 18-20 °C -> vêtir l'enfant comme on se vêtirait soi-même selon température ambiante
- Environnement sans fumée et sans animaux
- L'utilisation d'un monitoring cardio-respiratoire du commerce ne remplace aucune mesure !

PRÉVENTION ACCIDENTS

- **Ne pas hésiter à appeler à l'aide si burnout : risque de shaken baby syndrom !**
- **Siège auto :**
 - Face à l'arrière
 - Fixé sur siège arrière au milieu
 - Jusqu'à 12 mois et 9 kg.
- **Médicaments** et produit toxiques enfermés en hauteur hors de portée
- **Cuisine** = lieu dangereux (four, plaques chaudes, brûlures, H₂O, huile, objets tranchants)
- **Bijoux / objets rituels** : pas de collier / bracelet pendant le sommeil sans surveillance
- Surveillance sur la **table à langer**
- **Prévention voyage :**

- Pas d'exposition au soleil de 10-16h, habits coton manche longues, chapeau et parasol obligatoires
- Protection anti-moustique (pas de spray < 6 mois), moustiquaire
- Repas fréquent pour éviter déshydratation
- Vaccins si voyages dans les zones endémiques : TB, HAV,
- Vaccins habituels
- Avion : équilibrer les pression oreille moyenne / externe par tétées au décollage et à l'atterrissage.

PRÉVENTION DE LA PLAGIOCÉPHALIE POSITIONNELLE

- S'assurer que pendant les périodes d'éveil, le nourrisson passe un certain temps dans des positions variées (décubitus latéral et dorsal)
- Changer d'orientation du bébé dans son lit . La fréquence recommandée de changement d'orientation au coucher varie de 1-2x/j à 1-2x/semaine.

DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

MOTEUR

- 2 mois: mains ouvertes
- 4 mois: tête dans l'axe, regard des mains
- 6 mois: transfert, pas de préférence manuelle
- 9 mois: assis, pré-locomotion
- 10-18 mois: marche
- Dès 12 mois: préférence manuelle, pince fine

PSYCOSOCIAL

- 2 mois: sourire réponse, social
- Dès 4 mois: ouvert, curieux
- 8 mois: peur de l'étranger
- 12 mois: le doudou
- 18 mois: début opposition, autonomie
- 3 ans: identification sexuelle, jeux de groupe
- 4 ans: séparation aisée

LANGAGE

- 2 mois: vocalises
- 6 mois: dissyllabes
- 12 mois: chaînes de syllabes, 1er mots, pointage
- 18 mois: jargon mélodieux
- 24 mois: > 50 mots, juxtapositions
- 3 ans: > 50% compréhensible par étranger
- 4 ans: 100% compréhensible

INTELLIGENCE

- 2 mois: habitation
- 4 mois: regard des mains
- 12 mois: permanence objet, cause-effet
- 18 mois: reconnaissance formes, puzzles, tours de plots
- 4 ans: puzzles, comptage (ad 4-5), imitations

CONSULTATION DE L'ADOLESCENT

PROGRAMME DE LA CONSULTATION

Durée de 20 à 40 minutes

- Version de l'adolescent/des parents
- Place des parents? Qui a voulu venir?
 - 1er entretien à seul avec l'adolescent
 - Ecouter la version de l'adolescent et la version des parents
 - Prévoir quelques minutes à la fin pour parler avec le parent/tuteur
- Rappeler les règles de confidentialité

CADRE

- Tutoyer ou vouvoyer ? Toujours demander au patient :
« *Est-ce que vous préférez que l'on se tutoie ou l'on se vouvoie?* »
Si ça lui est égal, préférer le tutoiement.
- Parler à seul avec l'adolescent mais aussi, en fin ou en début d'entretien avec les parents/accompagnateur
- Respecter des distances générationnelles
- Il est important de préciser que tout l'échange sera confidentiel.
« *Tu ce qui tu vas me dire reste et restera entre nous* ».
Exceptions :
 - Situations mettant directement l'adolescent en danger (menaces suicidaires ou grossesses à risque cachée)
 - Abus physique
 - Abus sexuels
 - Négligences parentales graves
- Attention agenda caché :
 - Problèmes prétextes pour tester la fiabilité de son interlocuteur
 - Plaintes somatiques masquant des difficultés psycho-sociales

ANAMNÈSE PSYCHO-SOCIALE: HEAADSSS

HABITAT

- Entourage :
 - « *Avec qui habites-tu ?* »
 - « *Comment décrirais-tu ta relation avec tes parents/tes proches? Est-ce que tu t'entends bien avec tes parents ?* »
- Soutien et ressources :
 - « *As-tu un adulte-ressource dans ton entourage ?* »
 - « *As-tu quelqu'un dans ton entourage en qui tu as confiance?* »
 - « *En général, sur qui comptes-tu en cas de coup dur?* »

EDUCATION

- Activité scolaire/professionnelle :
 - « *Qu'est-ce que tu fais comme études/travail?* »
 - « *Est-ce que tu vas à l'école ?* »
- Projets d'avenir :
 - « *Comment envisages-tu ton futur ?* »
 - « *Quels sont tes projets d'avenir ?* »
- Entente avec les professeurs/patron/collègues :
 - « *Comment ça se passe avec tes professeurs ?* »
 - « *Comment t'entends-tu avec tes professeurs/patrons/collègues?* »

ACTIVITÉS

- Activités créatrices :
 - « *Est-ce que tu fais des activités en-dehors des cours ?* »
 - « *Quels sont tes loisirs ?* »
 - « *Est-ce que tu pratiques un sport ?* »
 - « *Est-ce que tu joues un instrument de musique ?* »
 - « *Est-ce que tu suis des cours de peintures ?* »
- Appartenance au groupe de pairs: "*Est-ce que tu as dans ton entourage, des personnes ou un groupe de personnes sur qui tu peux compter?*" (NB: éviter le: "*Est-ce que tu as des amis?*")
- Signe d'appel:
 - Isolement
 - Changements fréquents d'amis

ALIMENTATION

- « *Comment est-ce que tu t'alimentes ?* »
- Nombre de repas pris : « *Combien de repas est-ce que tu prends par jour ?* »
- Petit déjeuner :
 - « *Est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ?* »
 - « *Est-ce que tu pourrais me décrire (pour toi) un petit déjeuner ordinaire?* »
- Type d'aliments pris : « *Quels aliments consommes-tu fréquemment?* »
- Troubles alimentaires : « *Est-ce que tu as des soucis avec ton alimentation/poids ?* »

DROGUES

- Usage/abus de drogues légales et illégales
- Usage/abus par l'entourage
 - Amis
 - Famille
 - Patient lui-meme
- Type d'usage
 - Fréquence & quantité
 - Situations
 - Âge du commencement de la consommation

SEXUALITÉ

- Connaissances
- Attitudes
- Orientation sexuelle
- Comportement, satisfaction⁶
- Contraception
- Abus

SANTÉ MENTALE, SUICIDE

- Humeur, troubles du sommeil
- Deuils récents, traumatisme, suicide dans l'entourage
- Projets suicidaire
- Tentative de suicide
- A explorer :
 - Fugues
 - Accidents
 - Violence

SÉCURITÉ

- Prise de risque au volant
- Culture du danger
- Rencontre avec la police
- Violence et bagarres

Si pathologies, conseiller un suivi pour déterminer la signification de certains comportements.

⁶ Ne pas avoir de relation sexuelle ne signifie pas qu'il n'a pas de sexualité.

EXAMEN PHYSIQUE

- Croissance et puberté: mesure régulière de la taille et du poids
- Organes des sens
- Examen orthopédique (colonne) -> les maladies du dos s'accroissent durant la puberté
- Peau (acné, apparence) -> rechercher l'impact psychosocial

CONCLUSION

- Résumer sur les principaux constats et énoncer des propositions.
- Commenter les anomalies mêmes mineures
- Proposer des éléments d'éducation pour la santé
- Laisser du temps à l'adolescent pour aborder « l'agenda caché »

ABORDER L'ADOLESCENT

- Pour le rassurer:
 - Expliquer la structure de l'entretien -> créer un cadre spatio-temporel
 - Rappeler les règles de confidentialité -> respect de son intégrité
- Poser des questions intimes et mettre à l'aise l'adolescent
 - Enoncés indirects:
« Certains jeunes de ton âge que j'ai rencontrés pensent que... qu'en penses-tu toi?/Cela te concerne-t-il aussi? »
 - Comparaison avec d'autres personnes du même âge:
« Dirais-tu que tu as plus de peine à contrôler ta violence que tes camarades? »
« Dirais-tu que tu es plutôt timide, plus déprimé que tes camarades? »
- Pour rassurer durant l'examen physique:
 - Rappeler que la vitesse de croissance et l'âge pubertaire présentent une très grande variabilité.
 - Expliquer et rassurer l'adolescent sur la normalité du fonctionnement de ses différents organes.
 - Rassurer l'adolescent sur ses inquiétudes face au corps en changements. Il est important de confirmer et légitimer la normalité des changements que l'adolescent subit.